

a4_discharge_parser 测试报告

生成时间：2026-05-18 14:51:03

测试时间：2026-05-18 14:51:03

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=956 markers=14

禁用工具 success=True chars=1001 markers=17

工具说明：tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_基础信息:tool_基础信息：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

《出院摘要结构化包》

****住院期间BPSD类型****：拒绝进食、拒绝配合照护、情绪躁动

****住院期间BPSD频次****：（未提供具体频次数据，留空）

****有效干预记录****：精神行为干预；非药物干预（包括陪伴交流、结合老人跳舞喜好的温和活动引导）

****无效干预记录****：（无相关信息，留空）

****药物调整项****：（未明确说明住院期间药物种类或剂量调整，留空）

****出院NPI评分****：16分

****出院ADL评分****：（未提供ADL评分，留空）

****触发因素清单****：（未明确列出BPSD加重的具体诱因，留空）

****高风险提示****：

- 跌倒高风险（需环境改造：清除地面障碍物、安装扶手）
- 心血管事件高风险（高血压、高胆固醇血症、心电图T波改变、心脏起搏器植入术后）
- BPSD症状复发高风险（可能出现情绪躁动、意识异常）

****出院医嘱**：**

1. 规律服用降压药（氨氯地平片 5mg qd）及调脂药（阿托伐他汀钙片 20mg qn），每日晨起监测血压并记录；
2. 避免剧烈活动及情绪刺激，落实跌倒防护措施；
3. 出院后3个月复查心电图，若出现情绪躁动或意识异常，应及时就诊；
4. 照护中重点关注认知相关行为，积极开展非药物干预，多陪伴交流，结合其喜爱跳舞的特点引导参与温和活动，以缓解BPSD症状；
5. 关注家属照护过程中的焦虑情绪，必要时提供心理支持，并指导家属掌握基础照护技巧及BPSD症状应对方法。

****返院承接建议**：**

照护机构应延续住院期间有效的非药物干预策略，将跳舞、哼唱老歌等兴趣活动融入日常照护计划；设置安全照护环境，预防跌倒；建立BPSD行为观察记录机制，重点关注拒绝照护、情绪波动等早期信号；与家属保持沟通，协同落实个体化照护方案。

****家属配合要求**：**

- 每日协助监测血压并记录；
- 坚持规律给药，确保降压及调脂治疗依从性；
- 主动陪伴交流，鼓励老人参与温和的兴趣活动；
- 学习并应用BPSD应对技巧，避免对抗性照护；
- 关注自身心理状态，必要时寻求专业心理支持。

****下次复诊建议时间**：**出院后3个月（用于心电图复查及整体健康评估）。

【禁用工具输出摘录】

****出院摘要结构化包****

****住院期间BPSD类型**：**

拒绝进食、拒绝配合照护、情绪躁动

****住院期间BPSD频次**：**

（未提供具体频次，留空）

****有效干预记录**：**

- 精神行为干预
- 对症支持治疗
- 非药物干预：增加陪伴与交流，结合老人跳舞及哼唱老歌的兴趣，引导参与温和活动

****无效干预记录**：**

（未提及，留空）

****药物调整项**：**

- 启动/规范化降压治疗：氨氯地平片 5mg 每日一次（qd）
- 启动/规范化调脂治疗：阿托伐他汀钙片 20mg 每晚一次（qn）

****出院NPI评分**：**

16分

****出院ADL评分**：**

(未提供，留空)

****触发因素清单**：**

(未明确具体诱因，留空)

****高风险提示**：**

- 跌倒高风险（需环境改造与防护）
- 心脏起搏器植入术后状态
- 高血压及高脂血症控制不佳史
- BPSD症状复发风险（尤其情绪躁动）

****出院医嘱**：**

1. 规律服用降压药（氨氯地平片 5mg qd）及调脂药（阿托伐他汀钙片 20mg qn）；每日晨起监测血压并记录。

2.

避免剧烈活动及情绪刺激；加强跌倒防护，家中及照护机构需清除地面障碍物、安装扶手。

3. 出院后3个月复查心电图；若出现情绪躁动、意识异常等，应及时就诊。

4. 照护中重点关注认知相关行为，持续开展非药物干预，多陪伴交流，结合其喜爱跳舞的特点，引导参与温和和文娱活动，以缓解BPSD症状。

5. 关注家属照护过程中的焦虑情绪，必要时提供心理支持，并指导其掌握基础照护技巧及BPSD应对策略。

****返院承接建议**：**

- 照护环境须完成适老化改造：清除地面障碍、加装卫生间及走廊扶手
- 制定个性化非药物干预计划，融入跳舞、哼唱等兴趣活动
- 建立每日血压监测与记录机制
- 照护人员需接受BPSD应对培训，重点掌握拒绝照护情境下的沟通技巧

****家属配合要求**：**

- 学习并实践基础照护技巧及BPSD症状应对方法
- 每日协助监测并记录血压
- 积极参与老人情绪安抚与兴趣活动引导
- 关注自身心理状态，必要时寻求专业心理支持

****下次复诊建议时间**：**

出院后3个月（用于心电图复查及综合评估）